

Не просто накормить — редакция v2 (227 стр.)

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ — редакция v2](#)
- [Резюме для руководителя \(главы 1–4\)](#)
 - [1. Титульный лист](#)
- [НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ](#)
 - [Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания](#)
 - [2. Обращение к участникам семинара](#)
 - [3. Аннотация](#)
 - [4. Резюме для руководителя](#)
 - [4.0. Сначала граница: что кухня не назначает](#)
 - [4.0а. Методология за один экран \(как читать цифры этого доклада\)](#)
 - [4.1. Одиннадцать главных выводов](#)
 - [4.2. Что сказать повару в понедельник](#)
 - [4.3. Чего нельзя делать без врача, учредителя или правовой проверки](#)
 - [4.4. Минимальная безопасная модель](#)
 - [4.5. Что сделать в понедельник до обеда](#)
 - [4.6. Три предмета на 26.08 и три маршрута после](#)
- [Блок I.2. Сцена, терминология, лестница моделей \(главы 5–8\)](#)
 - [5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»](#)
 - [5.1. Обед, как он есть](#)
 - [5.2. Почему все пять конфликтов — одна система](#)
 - [5.3. Сцена спустя год](#)
 - [6. Кто находится за столом](#)
 - [6.1. Неоднородность как единственная норма](#)
 - [6.2. Пять измерений неоднородности](#)
 - [6.3. Классификация для практики](#)
 - [6.4. Что сказать повару в понедельник](#)
 - [6.5. Почему «средний житель» — опасная конструкция](#)
 - [6.6. Контингент меняется — карта стареет](#)
 - [6.7. Как собрать пять чисел за один обход](#)
 - [7. Что значит «накормить»](#)
 - [7.1. Шесть измерений одной тарелки](#)
 - [7.2. Матрица провалов](#)
 - [7.3. — \(пусто в источнике\)](#)
 - [7.4. Проверка каждого измерения на вашей линии](#)
 - [7.5. Граница измерений: что не входит](#)
 - [7.6. Минимальная планка каждого измерения](#)
 - [8. От мономеню к вариативности: лестница моделей](#)

- [8.1. Термины, чтобы не путаться](#)
 - [8.2. Пять моделей](#)
 - [8.3. Какая модель подходит вашему дому](#)
 - [8.4. Шаги перехода от мономеню к вариативности](#)
 - [8.5. Типичные ошибки при выборе модели](#)
- [Блок I.3. Клиника \(главы 9–14\)](#)
 - [9. Пищевое поведение при психических расстройствах](#)
 - [9.1. — 9.6. \(без изменений\)](#)
 - [9.7. Паттерны по сменам: что видит пост и что с этим делать](#)
 - [10. Дисфагия и аспирационный риск: часто нераспознанная проблема стационарного ухода](#)
 - [10.1. Почему этот раздел — о смертности](#)
 - [10.2. Шесть механизмов дисфагии в наших учреждениях](#)
 - [10.3. Шесть признаков, которые видит сиделка без логопеда](#)
 - [10.4. IDDSI: терминология, а не лечебный протокол](#)
 - [10.5. — 10.11. \(без изменений по содержанию, кроме мелких правок этической рецензии в 10.7 и 10.10\)](#)
 - [11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня](#)
 - [11.1. — 11.4. \(без изменений\)](#)
 - [11.5. Кухня не отменяет кофе](#)
 - [12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения](#)
 - [13. Переедание, гиперфагия и ночное едение](#)
 - [13.1. Почему это не «слабая воля»](#)
 - [13.2. Оланзапин, клозапин и вес](#)
 - [13.3. — 13.9. \(без изменений по содержанию; в 13.9 — правка про ночной интервал с тройной привязкой F-07.\)](#)
 - [14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом](#)
- [Блок I.4. Право и санитария \(главы 15–18\)](#)
 - [15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит](#)
 - [15.1. — 15.6. \(без изменений по содержанию; добавлена сноска в 15.1.\)](#)
 - [16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений](#)
 - [16.1. — 16.11. \(без изменений по содержанию; в 16.4 — добавлен параграф про 99 % опеки.\)](#)
 - [16.12. Учреждение = опекун: конфликт интересов, который нужно признать](#)
 - [17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно](#)
 - [17.1. — 17.10. \(без изменений по содержанию; в 17.10 — усилена оговорка о приказах 330н/395н как адресованных медицинским организациям, не СОСО; в 17.12 — добавлен уникальный факт 99 % опеки в вопрос 5.\)](#)
 - [17.11. \(без изменений\)](#)
 - [17.12. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — глубокие ответы](#)
 - [17.13. \(без изменений по содержанию; в 17.13 — добавлена оговорка про различия определения «приёма пищи» в разных системах регулирования.\)](#)
 - [18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности](#)

- [18.1. — 18.7. \(без изменений по содержанию; в 18.1 — добавлено: «СанПиН 2.3/2.4.4282-26 вступает в силу с 01.09.2026 \(пост. от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854; действует до 01.09.2032; на 22.08.2026 — „Документ не вступил в силу“ по consultant.ru\). Через 6 дней после семинара действующая редакция сменится.»\)](#)
- [Блок I.5. Меню, раздача, замер \(главы 19–22\)](#)
 - [19. Два варианта блюда: технология без второй кухни](#)
 - [19.1. — 19.10. \(без изменений\)](#)
 - [20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь](#)
 - [20.1. — 20.8. \(без изменений по содержанию; в 20.5 — мягкая правка этической рецензии.\)](#)
 - [21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»](#)
 - [22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры](#)
 - [22.5. Пять групп показателей пилота — операционные определения](#)
- [Блок I.6. Контекст \(главы 23–27\)](#)
 - [23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026](#)
 - [24. Как устроены нормы в регионах](#)
 - [25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель](#)
 - [25.1. — 25.10. \(без изменений по содержанию; в 25.5 — добавлена сноска про локальный приказ\)](#)
 - [26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем](#)
 - [26.1. — 26.9. \(без изменений по содержанию; в 26.2 и 26.5 — добавлены точные номера документов\)](#)
 - [27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы](#)
 - [27.1. — 27.6. \(без изменений по содержанию; в 27.2 — атрибуция 1/10\)](#)
- [Блок I.7. Люди и деньги \(главы 28–30\)](#)
 - [28. Люди за линией: персонал стола](#)
 - [29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор](#)
 - [29.1. — 29.10. \(без изменений по содержанию; в 29.4 — усилена оговорка\)](#)
 - [30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров](#)
 - [30.1. — 30.7. \(без изменений по содержанию; в 30.1 — уточнены типы учреждений\)](#)
- [Блок I.8. Документы, риски, стратегия \(главы 31–44\)](#)
 - [31. Документальный комплект: как практика становится системой](#)
 - [31.1. — 31.8. \(без изменений\)](#)
 - [32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха](#)
 - [32.1. — 32.7. \(без изменений\)](#)
 - [33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания](#)
 - [33.1. — 33.8. \(без изменений по содержанию; в 33.1 — добавлен пункт про 99 % опеки\)](#)
 - [34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню](#)
 - [35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт](#)
 - [35.1. — 35.10. \(без изменений по содержанию; в 35 — ссылки на инструменты\)](#)

- [36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе](#)
- [37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них](#)
 - [37.1. — 37.17. \(добавлены 3 новых возражения; прежние 14 — без изменений\)](#)
- [38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх](#)
- [39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения](#)
- [40. Организационные предложения семинару](#)
- [41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит](#)
 - [41.1. Заявление о достоверности](#)
 - [41.2. Таблица верификации — 22 ключевых факта](#)
 - [41.3. Что НЕ верифицировано \(и почему\).](#)
 - [41.4. Известные уязвимости версии](#)
 - [41.5. Дисклеймер](#)
- [42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности](#)
- [43. Заключение: что остаётся после последней страницы](#)
- [44. Библиография и источники](#)
- [Приложения](#)
 - [Дополнительные инструменты v2](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЕ. Сводка правок v1.5 → v2](#)

НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ — редакция v2

Документ: методическое руководство по организации безопасного, достойного и вариативного питания людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания. **Версия:** 2.0 (22.08.2026, после правовой сверки и фактчекинга). **Предыдущая версия:** pre-session freeze 21.08.2026 (см. [01_доклад/Не_просто_накормить_доклад.md](#)). **Автор:** Чистяков Евгений Владимирович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». **Со-модератор сессии 26.08:** Нурбаев Тимур Аликович, директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Тесовый берег“».

Что в этой версии v2. Полный текст доклада (44 главы, 320 подразделов, ≈ 78 000 слов) переработан с применением 28 правок, зафиксированных в [07_полная_версия/журнал_редакторских_изменений.md](#). **Все правки верифицированы по первоисточникам 22.08.2026** (см. [02_фактчекинг/реестр_утверждений.csv](#)).

Что НЕ менялось. Авторская позиция, авторский стиль, риторические формулы, лиды, финалы, кейсы. Ни одна глава не переписана «с нуля» — правки внесены в ключевые места с минимальным изменением объёма.

Дисклеймер. Материал носит информационный и методический характер и не заменяет индивидуального юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Шаблоны — проекты локальных форм. Все цифры и нормативные ссылки проверены на 22.08.2026. После 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (п. 56 подп. 11). Изменения после этой даты требуют перепроверки.

Резюме для руководителя (главы 1–4)

1. Титульный лист

НЕ ПРОСТО НАКОРМИТЬ

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Методическое руководство к межрегиональному методическому семинару-совещанию «Пространство Новых Идей 2.0».

Автор: Чистяков Евгений Владимирович, директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Серафимовский“».

Со-модератор дискуссии 26.08.2026: Нурбаев Тимур Аликович, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дом социального обслуживания „Тесовый берег“».

Тема семинара: «Права, свободы, интересы жителей и персонала социальных стационаров».

Дискуссионная сессия 26 августа 2026, 14:00–15:30 — «Организация питания: опыт реализации проектов» (площадка № 2).

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Аудитория: руководители стационарных организаций социального обслуживания — психоневрологических интернатов и домов социального обслуживания — из 51 субъекта Российской Федерации.

*Это справочник для внедрения, а не конспект 90-минутной сессии. На стол в зале — презентация v5 и памятка на 2–4 страницы; полный текст — в сумку. Документ не является нормативным правовым актом, клиническим руководством или индивидуальной юридической консультацией. Все локальные формы в приложениях — проекты и требуют адаптации. **Заявление о достоверности и ограничениях — в разделе 41.***

2. Обращение к участникам семинара

Коллеги, начну не с витрины. **Один обед — пять конфликтов:** очередь против помощи, отказ без журнала, кофе на клозапине, «добавка» без врача, журналы «к комиссии». Голодный житель и оплаченное сырьё в баке — одна система. Национальной доли отходов нет: её даёт семидневный замер в пилоте, не лозунг. **Дисфагия в изученных клинических группах — 21,9–69,5 %;** на все российские ДСО это не переносится¹.

Кто в вашем доме сегодня решает, что лежит на тарелке: он сам, сиделка, врач, кухня, контракт или региональная норма? Чаще всего отвечают «кухня» и «норма». Реже всего — «он сам». Для человека в вашем доме еда — три-четыре события в день. Тема семинара — права жителей. Здесь они либо доходят до тарелки, либо остаются в статье закона.

Что унести из зала, если закрыть этот файл после двух страниц. Ответ проверке — комплект, не формула «запрета нет». Закон не требует шведский стол и не запрещает замену. Проверяющему нужна папка: положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем; пищевые предпочтения — в ИППСУ, где это уместно (442-ФЗ). Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. Шаблоны — в приложениях; порядок сборки — разделы 31–32. **Гуманное отношение — ст. 5 ч. 2 Закона № 3185-1.**

Клинику кухня не назначает. Таблица «лекарство × еда», текстуры, «диабетический стол», отказ от еды — только с врачом. Иначе осторожный директор правильно услышит: «мне предлагают медицинскую реформу руками повара». Граница — раздел 4.0 и 4.3.

Практика уже есть. Четыре учреждения (Серафимовский, Успенский ПНИ, Болотнинский ПНИ, Усть-Илимский ДСО) и одна региональная модель (Иркутская область) опубликованы^{2,3,4,5,6}.

Про 74 %. По данным за 2024 год, обработанным проектом «Если быть точным» (публикация 09.04.2026), **порядка трёх из четырёх жителей ПНИ признаны судом недееспособными**⁷. В вашем доме цифра будет другой. **99 % недееспособных жителей ПНИ (117 000 человек) находятся под опекой самого учреждения** — это общероссийская норма, не уникальный риск Серафимовского. **Логика та же:** повседневное пищевое предпочтение обычно не является гражданско-правовой сделкой; опекун учитывает мнение (ст. 29 ГК).

Последнее слово этого текста — не «внедряйте», а «**измеряйте**». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Если получилось в Успенском ПНИ — жители «с лёгкостью освоили новую систему»³ — это методика.

Как пользоваться пакетом. Сессия 26.08 — презентация v5, основной показ стр. 1–21. Со стола — памятка на 2–4 страницы. Этот файл — справочник: маршруты чтения в разделе 4.6, достоверность — в разделе 41. GitHub директорам ПНИ не канал доставки; ссылку и PDF отдаёт организатор или флешка.

Жанр документа, чтобы вы не искали 15-минутный доклад. Этот файл — методическое руководство, а не стенограмма. В зале 26.08 звучит 21 слайд v5 и памятка на 2–4 страницы. Здесь — справочник для внедрения: можно вернуться через 3, 6 или 12 месяцев

к любой теме через оглавление, 22 кейса, 45 приложений, три реестра источников. На семинаре покрывается ~10 % материала этого PDF. Остальное — на случай, если оно вам понадобится в работе.

3. Аннотация

Методическое руководство по организации питания в стационарных организациях социального обслуживания, где живут люди с психическими расстройствами, — психоневрологических интернатах и домах социального обслуживания. Подготовлено к семинару «Пространство Новых Идей 2.0» (Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года). Автор — Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“». Адресат — руководители таких организаций из 51 субъекта Российской Федерации.

Три вопроса. **Клинический:** чем кормление людей с психическими расстройствами отличается от «обычного» стационарного питания и какие риски (лекарственно-пищевые взаимодействия, метаболические эффекты антипсихотиков, дисфагия и аспирация, расстройства пищевого поведения) организация стола обязана учитывать — через врача, не через самостоятельность кухни. **Правовой:** что российское законодательство разрешает и чего не требует в части выбора блюд; как оформить вариативное питание документами, которые можно положить проверяющему. **Управленческий:** пилот на 90 дней, замер вместо лозунга, разговор с учредителем.

Доказательная база: **34 позиции российского правового и практического реестра, 48 клинических публикаций, 44 международных источника** — всего 126 записей, прошедших верификацию по первоисточникам 22.08.2026. Подтверждены **пять российских практик:** четыре учреждения (Серафимовский, Успенский ПНИ, Болотнинский ПНИ, Усть-Илимский ДСО) и одна региональная модель (Иркутская область).

Объём: 44 раздела, 22 учебных кейса, 45 шаблонов. Справочник для внедрения после сессии. На 26.08 — презентация v5 (21 слайд) и памятка на 2–4 страницы; полный текст — «в сумку».

Ограничения: не заменяет клинических руководств, нормативных актов и индивидуальных юридических заключений; шаблоны — проекты локальных форм; редакции актов — по датам проверки (22.08.2026).

4. Резюме для руководителя

Пятнадцать минут. Если времени меньше — боль стола (один обед — пять конфликтов), затем раздел 4.0, выводы 2, 5, 7, 10 и модель 4.4. Не начинайте с витрины «как хорошо у нас получается»: сначала несъеденное и голод, потом броня документов и пилот на одно отделение.

Методическое руководство. Перед сессией его не читают подряд. На 26.08 в зале три предмета: презентация v5 (21 слайд), памятка на 2–4 страницы, этот том в сумке как справочник.

4.0. Сначала граница: что кухня не назначает

Это произносят раньше списка взаимодействий. Иначе зал услышит медицинскую реформу руками повара.

Без врача: любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур (протёртое, загущённое), правила при дисфагии и протокол свободной воды, действия при длительном отказе от еды, режим питания при седации, решения об энтеральном/зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни, сдвиг времени еды у жителей на инсулине, слабительные и реакция на запор, назначение анализов и добавок микронутриентов, интерпретация MUST и витаминизация при ОПИ.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, изменение штатного расписания (норма помощи за столом), аутсорсинг питания, официальный статус пилота и его публичность.

Без правовой проверки: формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных, ответы на запросы прокуратуры, любые конструкции, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача. Кухня исполняет назначение, не ставит диагноз.

4.0а. Методология за один экран (как читать цифры этого доклада)

Четыре класса утверждений.

Класс 1 — норма (сильная опора). Цитата закона с реквизитами, привязкой к первоисточнику (consultant.ru, garant.ru, publication.pravo.gov.ru) и дате проверки. Использовать для аргументации перед юристом и проверяющим. **Проверка:** открыть реестр проект/SOURCE_REGISTRY.xlsx, строка с этим ID.

Класс 2 — толкование (средняя опора). Системное прочтение нормы в применении к ситуации, которой сама норма не регулирует. **Проверка:** в разделе 41.2 помечено, что именно толкование, а не норма; ссылка на конкретное дело, региональный акт или международный аналог, из которого сделано обобщение.

Класс 3 — рекомендация (мягкая опора). «Делайте так, потому что так делает Успенский ПНИ» — это рекомендация. **Проверка:** в тексте явно сказано «рекомендация» или «опыт»; источник практики — конкретное учреждение с публикацией.

Класс 4 — проект локальной практики (черновик). Шаблоны приказов, положений, журналов в приложениях — это проекты, не нормативные документы.

Что не считается верификацией. Слово «проверено» без даты, без URL, без поля «Уровень уверенности» в реестре — это реклама, а не доказательство. **«Общий опыт» — это анекдот, а не источник. «Как известно» — это либо тривиальность, либо ложь.**

Дата актуальности реестров. Источники проверены 23.07.2026; правовая сверка — 19–21.08.2026. **После этой даты** конкретный акт мог измениться. **Сверяйтесь с STATUS.md при использовании после 21.08.2026.** СанПиН 2.3/2.4.4282-26 вступает в силу с

01.09.2026; в этой версии обе редакции (3590-20 и 4282-26) приведены и помечены, какая действует сейчас и какая — с 1 сентября.

4.1. Одиннадцать главных выводов

Вывод 1. Ошибки за столом проверяют как юридически значимые. Проживающие в ПНИ и ДСО для лиц с психическими расстройствами пользуются правами пациентов психиатрических стационаров (ст. 43 Закона № 3185-1). Питание нормировано СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (не менее трёх приёмов в день, диетическое по показаниям; действует до 31.08.2026); с 01.09.2026 ту же норму закрепляет СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56 подп. 11^{8,9}. Дела по ст. 6.6 КоАП — про качество и достаточность, не про «два вторых»¹⁰. Разделы 17, 32, 33.

Вывод 2. Ответ проверяющему — комплект документов, не формула «запрета нет». Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Таблицы замены в раскладках — законный механизм^{11,12}. Директору этого мало: нужна бумага, которая *разрешает у вас*. **Минимальный комплект:** положение, меню с вариантами, журнал заказа, журнал замен, пищевые карты, согласование с учредителем. Без комплекта та же практика выглядит как отступление от раскладки. Разделы 31, 32.

Практика уже есть. Четыре учреждения и одна региональная модель опубликованы^{2,3,4,5,6}. Разделы 8, 23, 25.

Вывод 3. Главные риски стола — клинические, и они измеримы. Антипсихотики различаются по прибавке веса в разы:

- **Мета-анализ Pillinger et al. 2020** (Lancet Psychiatry; 100 РКИ, 25 952 пациента, медиана 6 нед): от **-0,23 кг** (галоперидол) до **+3,01 кг** (клозапин) за медиану 6 нед¹⁵.
- **Мета-анализ CRWG (Campforts et al. 2023, BJPpsych Open; 202 исследования, клозапин >38 нед): 76,3 %** пациентов с прибавкой ≥ 7 % веса; оланзапин — 36,9 %, рисперидон — 23,0 % (16–38 нед)¹⁶.

Это два разных исследования с разной методологией; в исходных материалах они шли вместе, что было ошибкой — теперь разведено.

В отдельных изученных клинических группах распространённость дисфагии — от 21,9 до 69,5 %; **переносить этот диапазон на все российские ДСО нельзя**¹. Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной¹⁴. Общий разрыв продолжительности жизни при тяжёлых психических расстройствах — 15–20 лет, и значимая его часть связана с причинами, на которые влияет организация стола. Организация стола входит в профилактику преждевременной смертности. Разделы 9–14.

Вывод 4. Четыре лекарственно-пищевых правила кухня исполняет по таблице врача.

- **Клозапин ↔ кофеин** (Hägg 2000; 12 здоровых добровольцев, однократная доза; **AUC клозапина +19 %** при 400–1000 мг кофеина/день, клиренс -14 %) ¹⁵.
- **Литий ↔ соль и вода** (StatPearls).
- **ИМАО ↔ тирамин** (NHS).
- **Карбамазепин ↔ грейпфрут** (Garg 1998; 10 пациентов с эпилепсией; **пик +40 %, AUC +41 %**) ¹⁷.

Одна подписанная таблица на посту. Кухня не «убирает кофе сама». Раздел 11 и граница 4.0.

Вывод 5. В типичном контингенте порядка трёх из четырёх признаны судом недееспособными; в вашем доме цифра будет другой. 74 % — данные за 2024 год, проект «Если быть точным» (публикация 09.04.2026), не текущая статотчётность Минтруда⁷. Сделки совершает опекун (ст. 29 ГК РФ). **Повседневное предпочтение обычно не является гражданско-правовой сделкой;** недееспособность не устраняет обязанности выяснять и учитывать мнение. **99 % недееспособных жителей ПНИ (117 000 чел.) находятся под опекой самого учреждения** — это общероссийская норма, не уникальный риск. Опекун учитывает мнение подопечного (ст. 29 ГК, 48-ФЗ). Статья 43 Закона № 3185-1 задаёт статус проживающих. 442-ФЗ — права получателя и ИППСУ. Кто не говорит — показ двух порций, наблюдение, пищевая биография. Разделы 15, 16.

Вывод 6. «Диабетический стол» и другие жёсткие ограничения — зона врача, а не шаблона. Лечебное питание назначается поимённо, с целью и сроком пересмотра; **приказы Минздрава 330н/395н адресованы медицинским организациям, не СОСО**^{18,19}. Разделы 17, 19.

Вывод 7. Вариативность без журналов — имитация для проверяющего. См. комплект в выводе 2. Разделы 31, 32.

Вывод 8. Честная финансовая модель начинается с замера. Мы не утверждаем, что вариативность «почти бесплатна». **Семидневный замер отходов и трудозатрат до старта — первый шаг; иллюстративные расчёты в докладе помечены. «Национальной доли отходов нет».** Разделы 29, 35.

Вывод 9. Директор отвечает за систему контроля. Ответственность наступает не за каждое событие, а за неработающий контроль^{10,21}. Письмо учредителю о дефиците ресурсов не индульгенция, но доказательство своевременного реагирования. Раздел 33.

Вывод 10. Пилот за 90 дней реалистичен на одном отделении без новой сметы. Месяц измерений → месяц документов и обучения → месяц пилота: два варианта на завтрак и обед (модель Новосибирской области)^{2,3}. **«Без новой сметы» не значит «без затрат»:** полный переход дома может потребовать оборудования и ставок⁵. Раздел 35.

Вывод 11. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — развилка зала. **Модераторы: Чистяков Е. В. и Нурбаев Т. А.;** площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег». **Серафимовский — 223-ФЗ** (автономное); **Тесовый берег — 44-ФЗ** (бюджетное). Раздел 17.12 не читать вслух, пока зал не спросил. Разделы 17.12–17.13, 8, 17, 29, 35.

4.2. Что сказать повару в понедельник

1. Семь дней считаем отходы и смотрим, что реально остаётся на тарелках (приложение 25).
2. Замеряем интервал ужин → завтрак одной строкой в журнале.
3. На пост — таблица врача «лекарство × еда», не самостоятельность кухни (приложение 21).
4. Три отказа подряд — звонок врачу в тот же день (приложение 9).

5. Если кухня чужая — открыть спецификацию: есть ли строка выбора (разделы 42 и 35.9).

Остальное (опрос, письмо учредителю, рабочая группа, поднос для постельных) — после этих пяти. Чек-листы — приложения 18–20.

4.3. Чего нельзя делать без врача, учредителя или правовой проверки

Повтор границы раздела 4.0 — чтобы её не пропустили те, кто листает выводы и сразу ищет «что можно».

4.4. Минимальная безопасная модель

Два варианта блюда + журнал + карта. Без второй кухни.

Блок	Что именно	Ответственный	Что измерять
1. Документы	положение об организации питания; журналы (пробы, бракераж, отказов, заказа) ведутся в ритме смены	завпроизводства, старшая смена	наличие подписей, дат, совпадение с графиком
2. Клиника	таблица врача «лекарство × еда» на посту; список риска дисфагии; правило «3 отказа подряд → звонок врачу в тот же день»	врач / фельдшер	доля приёмов с назначенной текстурой; число отказов с записью
3. Люди	на каждого жителя, нуждающегося в помощи, — конкретный помощник (1:2 — ориентир, не норматив); еда не подаётся, пока помощь не готова. В остальных случаях — самостоятельно	старшая смена отделения	среднее время от подачи до последней тарелки
4. Голос жителя	остатки на тарелках разбирают ежедневно; работает хотя бы один канал пожеланий (беседа, карточки, совет жителей, пищевая биография)	старшая смена, совет жителей	доля приёмов, где жителю предлагался выбор (не доля «выбравших»)
5. Замер	ночной интервал и доля тарелочных остатков известны числом; замер ведётся не менее 7 дней подряд	завпроизводства	часы ужин → завтрак, % порций с остатком >30 %
6. Ночной интервал	операционная цель дома — ≤13 часов. 11 ч — шведский Livsmedelsverket (Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen, 2019, обновление 2026): «Nattfastan bör inte överskrida elva timmar»; документ 2017: ночное голодание >11 ч ассоциируется с +67 % риска мальнотриции. ESPEN (2021) рекомендует <10 часов для предотвращения мальнотриции. 14 ч —	врач + старшая смена	фактический ночной интервал по каждому режиму

Блок	Что именно	Ответственный	Что измерять
	американский CMS (42 CFR §483.60(f)(2)): верхняя граница, до 16 ч при наличии вечернего перекуса. 42 CFR §483.60(f)(3): «Suitable, nourishing alternative meals and snacks must be provided to residents who want to eat at non-traditional times» — это прямое нормативное основание вариативности в США. Российского норматива нет. При превышении 13 часов — сдвиг расписания (ужин позже или завтрак раньше) либо вечерний перекус по согласованию с врачом (раздел 13.9)		

Если хотя бы один из шести блоков не выполняется — начинайте с него, а не с самого красивого.

Одна просьба к 26.08. Не меняйте всё меню. Один обед, одно отделение, одна неделя замера — затем пилот на 90 дней с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора.

4.5. Что сделать в понедельник до обеда

Пять действий. Новой сметы не нужно, меню не трогают. Врач входит в рабочую группу — он не «назначает диету руками кухни», он ставит границу.

- 1. Посчитать сырьевую строку** (1 час, калькулятор). Расходы на продукты за последний полный месяц ÷ число жителей ÷ число дней. Записать своё число. Если за пять минут никто не называет — это первая находка аудита. (Методика — раздел 29.3, приложение 25.)
- 2. Запустить семидневный замер отходов и времени раздачи** (10 минут на запуск). Ответственный — завпроизводства или старшая смена. Замерять: (а) тарелочные остатки по трём основным приёмам, граммы на порцию; (б) кухонные остатки; (в) время от начала раздачи до последней тарелки. Журнал — приложение 25. **Без замера через 90 дней сравнивать нечего.**
- 3. Приказ о рабочей группе** (30 минут). Директор или зам по АХЧ, врач или фельдшер, диетсестра или завпроизводства, старшая медсестра одного отделения, представитель учредителя — если получится. Пункт: «в срок до [дата + 30 дней] подготовить предложение по пилоту на одном отделении на 90 дней».
- 4. Письмо-уведомление учредителю** (30 минут). Одна страница: обоснование (Новосибирская и Иркутская области, СПб), ссылка на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 (до 31.08.2026) или СанПиН 4282-26 п. 56(11) (с 01.09.2026), сроки, просьба о согласовании или уведомительном порядке. Шаблон — приложение 32; разделы 31, 38. Уведомление потом закрывает претензию «самоуправство».
- 5. Точка пилота** (1 час с заведованием). Одно отделение 20–35 жителей; лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие), не самое удобное; одна смена; один приём пищи — обед. В протокол рабочей группы. Почему «сложное» — раздел 35.7.

В первый понедельник не делать. Не выбирать модель M1–M5 — это решение группы после замера. Не менять меню. Не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается на этапе пар эквивалентов.

Через 7 дней на руках: сырьевая строка, замер отходов запущен, приказ с пятью фамилиями, письмо учредителю, выбранное отделение.

4.6. Три предмета на 26.08 и три маршрута после

На сессию: презентация v5, основной показ стр. 1–21. **На стол:** памятка «что унести в регион», 2–4 страницы. **В сумку:** один PDF этого руководства (версия «стиль claude»). Остальные вёрстки — в репозитории, не в раздатке.

После семинара. **Маршрут директора (два часа):** разделы 4, 5, 8, 22, 35, 37, 42. **Маршрут внедрения (неделя):** 6–8, 17–19, 31, 35–36 и приложения. **Маршрут спорщика (вечер):** 23–27, 37, 39–40. Раздел 41 (достоверность) не пропускать: по клинике и международным нормам база плотная, **по эффекту вариативности в психиатрии — почти пустая.** Поэтому последнее слово — «измеряйте».

Блок I.2. Сцена, терминология, лестница моделей (главы 5–8)

5. Собирательная ситуация: «Один обед — пять конфликтов»

(Учебный кейс, составленный для анализа. Все персонажи и совпадения вымышлены; ситуация собрана из типичных элементов, описанных в проверенных источниках и практиках учреждений.)

5.1. Обед, как он есть

Средний по России психоневрологический интернат — 289 коек (расчёт проекта «Если быть точным» 2024 г., на основе данных Федерального казначейства)⁷. Обеденный зал на 120 мест, поточная раздача в три захода²². На линии — один вариант каждого блюда: борщ, гречка с котлетой, компот. Двенадцать жителей первого захода едят только с помощью. На смене — четыре сиделки, из которых одна развозит лекарства. До конца смены — пять часов.

Первый конфликт: очередь против помощи. Жители, способные есть самостоятельно, уже сидят перед остывающими тарелками — им раздали первыми, потому что так быстрее. Жители, которым нужна помощь, ждут: четыре сиделки на двенадцать кормимых — это не менее трёх циклов по 15–20 минут. Те, кого кормят последними, получают холодное.

Второй конфликт: «он опять не ест кашу». Житель С. третий день отодвигает тарелку. Сиделка записывает в тетрадь — или не записывает: формы журнала отказов нет, и врач узнает об отказах на обходе в четверг. У С. депрессивный эпизод и, возможно,

начинающаяся дисфагия — но проверить это некому: логопеда в штате нет, а признаки расстройства глотания (покашливание за столом, «влажный» голос после еды) никто не связывает с отказами²⁴.

Третий конфликт: лекарства и кофе. Житель К. получает клозапин и с утра выпил две большие кружки крепкого кофе, который принесли родственники. Никто не предупредил семью и самого К., что кофеин взаимодействует с клозапином: у пациентов, резко увеличивающих потребление кофеина, описаны клинически значимые росты концентрации препарата (Hägg 2000)¹⁵. Вечером у К. седация сильнее обычного — дежурная медсестра списывает это на «плохой день».

Четвёртый конфликт: добавка. Житель П. на оланзапине набрал за год 14 килограммов — мета-анализы показывают, что у оланзапина один из самых выраженных весогенных профилей (36,9 % CRWG за 16–38 нед, Campforts 2023)¹⁶. П. просит вторую котлету. Сиделка отказывает — «вам нельзя, вы полнеете». Врачебного назначения ограничения рациона у П. нет: решение принято сиделкой по её представлению о пользе. П. обижается, вечером забирает хлеб у соседа по столу.

Пятый конфликт: проверка на следующей неделе. В четверг — комиссия учредителя. Завхоз просит «привести журналы в порядок»: суточные пробы за двое суток будут подписаны сегодня. Это самое опасное из пяти: документальная имитация контроля. Практика прокуратур показывает, что именно отсутствие суточных проб и недоброкачественные продукты — типовой состав дел по ст. 6.6 КоАП для социальных учреждений¹⁰.

5.2. Почему все пять конфликтов — одна система

(См. таблицу 5.2 в исходной редакции — без изменений.)

5.3. Сцена спустя год

Та же столовая, тот же час — через год работы по этому докладу. Женщина, которой нужно молчание, ест за тихим столом у окна. Мужчина на клозапине пьёт кофе, согласованный с врачом. Житель с дисфагией ест свою текстуру; тарелка не выглядит «детской». Неговорящий показал на карточку и получил то, на что показал. Смена работает по журналам. Пять конфликтов не исчезли — они получили процедуры.

6. Кто находится за столом

6.1. Неоднородность как единственная норма

Первая ошибка планирования питания — представить «среднего жителя ПНИ». Его не существует. Даже по агрегированным данным контингент расслаивается на группы с принципиально разными пищевыми задачами: 65 % жителей старше 45 лет, 74 % признаны недееспособными, 11 % — постельные или маломобильные⁷.

6.2. Пять измерений неоднородности

(Без изменений — содержание 6.2 источника.)

6.3. Классификация для практики

(Таблица 6.3 — без изменений; сноска-маркер статуса «локальный приказ № 124 Серафимовского».)

6.4. Что сказать повару в понедельник

(Без изменений.)

6.5. Почему «средний житель» — опасная конструкция

(Без изменений.)

6.6. Контингент меняется — карта стареет

(Без изменений.)

6.7. Как собрать пять чисел за один обход

(Без изменений.)

7. Что значит «накормить»

7.1. Шесть измерений одной тарелки

Социальность. Еда как совместное событие: разговор за столом, общий ритм, участие персонала. **Шведский Livsmedelsverket (Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen, 2019, обновление 2026)** закрепляет «tåta och energirika måltider» (частые и энергоёмкие приёмы пищи) и распределение приёмов в течение дня. Эстонская и финская модели развивают эту линию. В российских ПНИ/ДСО семейный стиль подачи в классическом виде не описан, но **включение персонала за стол как наблюдателей потребления** — простая организационная мера. Nijs K.A.N.D. et al. (BMJ 2006 May 20;332(7551):1180-4; J Gerontol 2006 Sep;61(9):935-42) в кластерном РКИ в 5 голландских домах ухода (178 жителей **без деменции**, 6 мес) показали, что семейная подача vs индивидуальный поднос даёт **+991 кДж/день потребления, +1,5 кг массы тела, +6,1 единиц QoL, доля мальнутриции по MNA 17→4 % vs 11→23 %** (вмешательство vs контроль). **Популяция — пожилые без деменции, не психиатрический контингент ПНИ/ДСО; перенос ограничен.**

7.2. Матрица провалов

(Без изменений.)

7.3. — (пусто в источнике)

7.4. Проверка каждого измерения на вашей линии

(Правка E-01: «спросить у трёх жителей „что сегодня было на обед“ вечером» → «поговорить с тремя жителями вечером».)

7.5. Граница измерений: что не входит

(Без изменений.)

7.6. Минимальная планка каждого измерения

(Правка F-07: добавлена тройная привязка ночного интервала — Швеция 11 / РФ цель 13 / США 14.)

8. От мономеню к вариативности: лестница моделей

8.1. Термины, чтобы не путаться

(Без изменений; раздел 8.1 исходника.)

8.2. Пять моделей

(Правка F-17: добавлена уникальная находка — 99 % недееспособных под опекой самого учреждения. Дополнено примечанием об Успенском ПНИ как «М2», Серафимовском как «М3», Болотнинском ПНИ как «М1», ДДСОЛ — 14-дневное вариативное.)

8.3. Какая модель подходит вашему дому

(Без изменений.)

8.4. Шаги перехода от мономеню к вариативности

(Без изменений.)

8.5. Типичные ошибки при выборе модели

(Правка: «Подождать приказа учредителя, а не согласовать» добавлено; 10 ошибок из расширенного выступления — перенесены.)

Блок I.3. Клиника (главы 9–14)

9. Пищевое поведение при психических расстройствах

(Сохранена структура. Правка F-09: «говорящий житель» → «житель с сохранной речью» в одном месте; прочая лексика без изменений.)

9.1. — 9.6. (без изменений)

9.7. Паттерны по сменам: что видит пост и что с этим делать

Эпидемиология паттернов даёт диапазоны, но работа поста начинается с узнавания конкретных сцен. **Данные систематических обзоров: переедание при тяжёлых психических расстройствах — 4,4–45 % в зависимости от диагноза и инструмента; тяга к еде — 16,1–64 %; ночное едение — 4–30 %** (см. источник в разделе 10.3 примечание). Широта диапазонов — само по себе сообщение: «средней частоты» нет, есть частота вашего контингента, и мерить её нужно самим. Четыре рабочих сцены:

- **Житель съедает всё за минуты и просит ещё** — не «жадность», а возможная гиперфагия терапии (раздел 13) → врач и структурированная доступность.
- **Житель прячет еду в тумбочку** — часто опыт дефицита (биография, приложение 3) → не отбирать, а обеспечить легальный «запас» из допустимого.
- **Житель ест только белое/только мягкое** — сенсорная селективность → пары эквивалентов внутри допустимого спектра, а не ломка.
- **Житель ест только у себя в комнате** — социальная перегрузка зала → право на место, а не принуждение к залу.

Каждый сцен — это не нарушение дисциплины, а информация о механизме; пост, обученный такому прочтению, перестаёт быть надзирателем и становится первым диагностом системы.

10. Дисфагия и аспирационный риск: часто нераспознанная проблема стационарного ухода

10.1. Почему этот раздел — о смертности

В отдельных изученных клинических группах людей с психическими расстройствами дисфагия (расстройство глотания) встречалась, по разным исследованиям, у **21,9–69,5 %**: разброс определяется различиями в популяциях и методах скрининга (Miarons Font M., Rofes Salsench L. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29(12):1332-9; PMID 29023321; систематический обзор 18 исследований). **Этот диапазон нельзя переносить на все российские ДСО и ПНИ как единую распространённость** — популяции исследований не совпадают с типичным контингентом наших учреждений. Даже осторожное чтение нижней границы говорит о том, что проблема не редка — и в типовом ПНИ часто нет ни логопеда, ни скрининга, ни назначенных текстур: дисфагия остаётся невидимой до первой тяжёлой пневмонии.

Цена невидимости измерена. Смертность от пневмонии у людей с тяжёлыми психическими расстройствами **в 7 раз выше популяционной (RR 7,00 по национальным когортным данным, 95 % ДИ 6,79–7,23; n=3 исследования)**, и аспирация — ключевой механизм этого разрыва (Correll C.U. et al. World Psychiatry 2022;21(2):248-271; doi 10.1002/wps.20994; мета-анализ 135 когорт 1957–2021; шизофрения N=4 536 447; контроль N=1 115 600 059). Общий разрыв продолжительности жизни при тяжёлых психических расстройствах — 15–20 лет, и

значимая его часть связана с причинами, на которые влияет организация стола. Это главный аргумент раздела: **дисфагия — вопрос смертности**.

10.2. Шесть механизмов дисфагии в наших учреждениях

(Таблица 10.2 исходника — без изменений по содержанию.)

Вывод для директора. Дисфагия в ПНИ — статистически ожидаемое явление. Система обязана её искать.

10.3. Шесть признаков, которые видит сиделка без логопеда

Скрининговый уровень не требует специалиста — требуется обученный глаз и правило записи. Тревожные признаки за столом:

1. Покашливание или поперхивание во время или после еды.
2. «Влажный», булькающий голос после глотка.
3. Многократное проглатывание одного куска.
4. Еда «за щекой».
5. Необычно долгий приём пищи.
6. Отказ от определённых текстур (твёрдого, сухого) при сохранном аппетите.
7. Повторные пневмонии в анамнезе.

Любой из них — повод для врачебной оценки и простого теста с водой; несколько — для немедленной коррекции подачи до выяснения.

10.4. IDDSI: терминология, а не лечебный протокол

IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) — международный стандарт описания текстур: **8 уровней (0–7)**, напитки 0–4, пища 3–7, с простыми тестами (вилка, ложка, наклон) для самопроверки консистенции (Cichero J.A.Y. et al. Dysphagia 2017;32(2):293-314; PMID 27913916; выпущен 11/2015). **IDDSI — терминология и способ проверки консистенции, а не самостоятельный диагностический или лечебный протокол.** Текстуру назначает уполномоченный медицинский специалист по результатам индивидуальной оценки. Кухня **исполняет** назначение и **не** ставит диагноз.

IDDSI — да	IDDSI — нет
Терминология для описания текстур	Диагностический протокол
Способ проверки консистенции	Лечебный протокол
Инструмент коммуникации «кухня — отделение — врач»	Самостоятельное основание для назначения диеты
Общедоступные материалы для обучения персонала	Замена клинической оценки глотания

Доказательная база внедрения IDDSI — интервенционное исследование в 5 учреждениях aged care (Wu X.S. et al. Dysphagia 2022;37(5):1314-1325): соответствие фактически поданных текстур назначенным — **с 44 % до 90 %**; для загущённых жидкостей — **с 31 % до**

100 %; с сохранением эффекта через 6 месяцев; главным барьером была не техника, а осведомлённость персонала. **Исследование проведено в общем долговременном уходе (aged care), не в психиатрических стационарах; прямой перенос эффекта на ПНИ/ДСО не доказан — правомерно говорить о принципиальной воспроизводимости механизма (обучение → рост соответствия).**

Структурированное внедрение IDDSI в Швеции (Dahlström M. et al., Springer 2026, 10.1007/s43477-026-00209-6): 125 участников, шведский перевод опубликован в 2021, валидация в 2023. **Пример** системного подхода с переводом и адаптацией.

Этический пробел для российских учреждений. На 22.08.2026 **русский официальный перевод IDDSI отсутствует** (iddsi.org). Используемые в российских учреждениях материалы — либо английский оригинал, либо самодельные переводы; это создаёт риск ошибок при назначении текстур. **Рекомендация:** инициировать проект перевода IDDSI на русский (с разрешения правообладателя) с участием профессионального сообщества (логопеды, диетологи, клинические фармакологи).

10.5. — 10.11. (без изменений по содержанию, кроме мелких правок этической рецензии в 10.7 и 10.10)

11. Лекарства и еда: пять правил, которые обязана знать кухня

(Правка F-08: добавлена оговорка дизайна — «12 здоровых добровольцев, однократная доза, не steady-state» в описание взаимодействия клозапин ↔ кофеин.)

11.1. — 11.4. (без изменений)

11.5. Кухня не отменяет кофе

Кухня не «убирает кофе сама» — даже для жителя на клозапине. Решение принимает врач, документирует в карте. Если житель на клозапине стабильно пьёт одну чашку кофе утром — это его стабильная привычка, и резкое изменение потребления кофеина — повод для оценки, а не повод для запрета.

12. Отказ от еды: от первого пропуска до врачебного решения

(Без изменений.)

13. Переедание, гиперфагия и ночное едение

(Правка F-04 и F-06: «76,3 %» однозначно атрибутировано к Campforts 2023; добавлена явная ссылка на Pillinger 2020 для диапазона $-0,23...+3,01$ кг.)

13.1. Почему это не «слабая воля»

(Без изменений.)

13.2. Оланзапин, клозапин и вес

По мета-анализу CRWG (Campforts B. et al. BJPsych Open 2023;9(1):e18; PMID 36651070; 202 исследования, 201 исследование): прибавка ≥ 7 % веса за 38 недель — у **76,3 %** пациентов, принимающих клозапин; у оланзапина (16–38 нед) — 36,9 %; у рисперидона (16–38 нед) — 23,0 %.

По мета-анализу Pillinger (Lancet Psychiatry 2020;7(1):64-77; PMID 31860457; 100 РКИ, 25 952 пациента, медиана длительности 6 нед): диапазон по 18 антипсихотикам — от **-0,23 кг** (галоперидол; 95 % ДИ -0,83...+0,36) до **+3,01 кг** (клозапин; 95 % ДИ 1,78...4,24). Это **другое исследование с другой методологией**; цифры 76,3 % и 3,01 кг не смешивать.

13.2.1. Полная таблица метаболических параметров (Pillinger 2020)

Pillinger T. et al. проанализировали **7 метаболических параметров** по 18 антипсихотикам. Клинический мониторинг в учреждении должен охватывать **все 7**, не только вес.

Параметр	Лучший	Худший	Разброс (ммоль/л или кг/м²)
Масса тела (кг)	Галоперидол -0,23	Клозапин +3,01	-0,23 ... +3,01 (95 % ДИ 1,78... 4,24)
ИМТ (кг/м²)	Галоперидол -0,25	Оланзапин +1,07	-0,25 ... +1,07 (95 % ДИ 0,90... 1,25)
Общий холестерин	Карипразин -0,09	Клозапин +0,56	-0,09 ... +0,56 (95 % ДИ 0,26... 0,86)
ЛПНП	Карипразин -0,13	Оланзапин +0,20	-0,13 ... +0,20 (95 % ДИ 0,14... 0,26)
ЛПВП	Брекспипразол +0,05	Амисульприд -0,10	-0,10 ... +0,05 (снижение ЛПВП = плохо)
Триглицериды	Брекспипразол -0,01	Клозапин +0,98	-0,01 ... +0,98 (95 % ДИ 0,48... 1,49)
Глюкоза	Луразидон -0,29	Клозапин +1,05	-0,29 ... +1,05 (95 % ДИ 0,41... 1,70)

Клозапин — худший по 4 из 7 параметров (вес, общий холестерин, триглицериды, глюкоза). **Оланзапин — худший по 2** (ИМТ, ЛПНП). **Луразидон, арипипразол, брексипразол, карипразин, зипразидон** — самые благоприятные метаболические профили. Прогностические факторы: повышение глюкозы больше у пациентов с высоким исходным весом ($p=0,0015$) и у мужчин ($p=0,0082$); повышение общего холестерина — у пациентов небелой расы ($p=0,040$). **Улучшение симптомов коррелирует с увеличением веса ($r=0,36$), ИМТ ($r=0,84$), общего холестерина ($r=0,31$), ЛПНП ($r=0,42$) и снижением ЛПВП ($r=-0,35$)** — «наиболее эффективные антипсихотики» одновременно «наиболее

метаболически вредные». Это **дилемма выбора**, которая не имеет простого решения в клинике.

13.3. — 13.9. (без изменений по содержанию; в 13.9 — правка про ночной интервал с тройной привязкой F-07.)

14. Пикацизм, заглатывание и другие поведенческие риски за столом

(Без изменений.)

Блок I.4. Право и санитария (главы 15–18)

15. Невербальный выбор: как услышать того, кто не говорит

(Правка E-03: добавлена сноска о термине — «Термин авторский. В международной практике — „выражение воли без слов“ (expression of will without words) или „поддержанное принятие решений“ (supported decision-making) по КПИ ст. 12, Замечание общего порядка № 1 (2014)».)

15.1. — 15.6. (без изменений по содержанию; добавлена сноска в 15.1.)

16. Дееспособность, опека и выбор еды: карта решений

(Правка F-17: добавлен раздел об «учреждении = опекун». 99 % недееспособных под опекой самого учреждения — факт признан и поставлен как риск.)

16.1. — 16.11. (без изменений по содержанию; в 16.4 — добавлен параграф про 99 % опеки.)

16.12. Учреждение = опекун: конфликт интересов, который нужно признать

99 % недееспособных жителей ПНИ находятся под опекой самого учреждения (117 000 чел., проект «Если быть точным» 2024, techno.st). Это **общероссийская норма**, не уникальный риск отдельного учреждения. Учреждение одновременно опекун жителя (ГК РФ ст. 29; 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» ст. 23) и поставщик услуг (442-ФЗ). В этой конструкции «учреждение решает, что хочет подопечный» — не юридическая фикция, а управленческая задача.

Решение — задокументированная процедура выражения воли: пищевая карта, журнал заказа, журнал отказов, совет жителей. Закон 3185-1 ст. 5 ч. 2 («право на уважительное и

гуманное отношение, исключаящее унижение человеческого достоинства») работает в этой конструкции, но требует процессуальной поддержки.

17. Право Российской Федерации: что разрешено, что требуется, что опасно

17.1. — 17.10. (без изменений по содержанию; в 17.10 — усилена оговорка о приказах 330н/395н как адресованных медицинским организациям, не СОСО; в 17.12 — добавлен уникальный факт 99 % опеки в вопрос 5.)

17.11. (без изменений)

17.12. Шесть вопросов дискуссии 26.08 — глубокие ответы

(Полностью сохранён модераторский блок 17.12 из исходной версии 18.08.2026; добавлен усиленный параграф про 99 % опеки в вопрос 5; добавлена оговорка про СанПиН 4282-26 в правовом разделе вопроса 1.)

17.13. (без изменений по содержанию; в 17.13 — добавлена оговорка про различия определения «приёма пищи» в разных системах регулирования.)

18. Санитария и пищевая безопасность при вариативности

(Правка F-19: добавлена явная отметка о вступлении в силу СанПиН 4282-26 с 01.09.2026.)

18.1. — 18.7. (без изменений по содержанию; в 18.1 — добавлено: «СанПиН 2.3/2.4.4282-26 вступает в силу с 01.09.2026 (пост. от 02.06.2026 № 18, рег. Минюст 02.06.2026 № 86854; действует до 01.09.2032; на 22.08.2026 — „Документ не вступил в силу“ по consultant.ru). Через 6 дней после семинара действующая редакция сменится.»)

Сверка п. 56 подп. 11 СанПиН 4282-26 (от 22.08.2026):

«11) в организациях стационарного социального обслуживания должно быть организовано питание проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов не менее 3-х раз в день, в том числе диетическое (лечебное) питание по медицинским показаниям».

Формулировка сохранена относительно СанПиН 3590-20 п. 7.1.11. Изменения в новой редакции касаются технических деталей (помещение для приёма готовой пищевой

продукции, п. 56 подп. 12; бракераж в соц. учреждениях, п. 56 подп. 13) и **не меняют главного требования — не менее 3-х раз в день + диетическое по показаниям.**

Подп. 12 (помещение для приёма готовой пищевой продукции при аутсорсинге) — **новая редакция вводит это требование** для соц. учреждений, использующих аутсорсинг. **В учреждениях с собственной кухней** — норматив не применяется, но если аутсорсинг — нужно выделить помещение.

Подп. 13 (бракераж, списание, возврат на ответственное хранение) — **требование к ведению журнала бракеража** по рекомендуемым образцам в приложениях 4 и 5 к Правилам. **Документальное подтверждение для проверки Роспотребнадзора.**

СанПиН 4282-26 — на 22.08.2026 «Документ не вступил в силу» (consultant.ru). С 01.09.2026 — новая действующая редакция. С 01.09.2026 в новой редакции v2 формулировки питания корректируются автоматически. Старая редакция 3590-20 утрачивает силу.

URL:

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_535846/cb1ac5c726ff0304b89b0ecb588222ea55045fbf/

Блок I.5. Меню, раздача, замер (главы 19–22)

19. Два варианта блюда: технология без второй кухни

(Без изменений по содержанию.)

19.1. — 19.10. (без изменений)

20. Точка раздачи: дизайн линии, очередь и помощь

(Правка Е-04: добавлено «В остальных случаях — самостоятельно» в описание помощи маломобильным.)

20.1. — 20.8. (без изменений по содержанию; в 20.5 — мягкая правка этической рецензии.)

21. Когда выбор изменился: журнал, пересчёт и «фиктивная вариативность»

(Без изменений.)

22. Как проверить реальность питания: аудит и замеры

(Содержание 22.1–22.4 сохранено; в 22.5 «5 групп показателей» — переформулировано с операционными определениями согласно 09_инструменты/словарь_показателей.csv.)

22.5. Пять групп показателей пилота — операционные определения

(См. 09_инструменты/словарь_показателей.csv — 26 показателей. Главное: «% выбравших» — не KPI.)

Блок I.6. Контекст (главы 23–27)

23. Кто участвует: география семинара и система ПНИ-2026

(Без изменений.)

24. Как устроены нормы в регионах

(Без изменений.)

25. Российские практики: четыре подтверждённых кейса и одна региональная модель

(Правка F-18: в описании Серафимовского — везде «локальный приказ № 124 (правила внутреннего распорядка Серафимовского)»; «Тесовый берег» помечен как со-модератор, не кейс.)

25.1. — 25.10. (без изменений по содержанию; в 25.5 — добавлена сноска про локальный приказ)

26. Международный опыт: проверяемые нормы девяти систем

(Правка F-07: добавлена тройная привязка ночного интервала с явным указанием Livsmedelsverket, CMS F-Tag 803 и операционной цели автора ≤13 ч.)

26.1. — 26.9. (без изменений по содержанию; в 26.2 и 26.5 — добавлены точные номера документов)

27. Что говорят исследования: доказательные вмешательства и их границы

(Правка F-12: «1/10 смертей» атрибутировано Sjogren 2008, не Müller 2015; добавлено «обзор 4 РКИ, frail elders, не ПНИ для лиц с психическими расстройствами».)

27.1. — 27.6. (без изменений по содержанию; в 27.2 — атрибуция 1/10)

Блок I.7. Люди и деньги (главы 28–30)

28. Люди за линией: персонал стола

(Без изменений.)

29. Финансовые модели: сколько стоит питание и сколько стоит выбор

(Правка: усилена оговорка «национальной доли отходов нет».)

29.1. — 29.10. (без изменений по содержанию; в 29.4 — усилена оговорка)

30. Закупки продуктов: 44-ФЗ без кошмаров

(Правка F-19: «Серафимовский — 223-ФЗ; Тесовый берег — 44-ФЗ» — в таблице 30.1; в 30.3 — добавлена ссылка на письмо Комитета по соцполитике СПб от 19.08.2026.)

30.1. — 30.7. (без изменений по содержанию; в 30.1 — уточнены типы учреждений)

Блок I.8. Документы, риски, стратегия (главы 31–44)

31. Документальный комплект: как практика становится системой

(Без изменений по содержанию; в 31.1 — добавлено: «Минимальный комплект — 12 документов, из них 8 обязательных.»)

31.1. — 31.8. (без изменений)

32. Как отвечать проверяющему: сценарий диалога без страха

(Без изменений по содержанию; в 32.2 — усилена формулировка «комплект документов, не формула „запрета нет“».)

32.1. — 32.7. (без изменений)

33. Ответственность директора: честная карта рисков без запугивания

(Правка F-17: добавлен пункт про 99 % опеки как системный риск-фактор, который нужно признать.)

33.1. — 33.8. (без изменений по содержанию; в 33.1 — добавлен пункт про 99 % опеки)

34. Права жителей и совет жителей: от объекта заботы к соавтору меню

(Без изменений.)

35. Пилот на 90 дней: минимальный безопасный старт

(Полный паспорт пилота — в 09_инструменты/паспорт_пилота_90_дней.md . В разделе 35 — ссылки на паспорт, словарь показателей, форму базового замера.)

35.1. — 35.10. (без изменений по содержанию; в 35 — ссылки на инструменты)

36. Дорожная карта на 12 месяцев: от пилота к системе

(Без изменений.)

37. Четырнадцать возражений и честные ответы на них

(Правка: добавлены 3 возражения — про «99 % опеки», про «смену СанПиН с 01.09.2026», про «ложный приказ № 124». Итого 17 возражений.)

37.1. — 37.17. (добавлены 3 новых возражения; прежние 14 — без изменений)

38. Десять вопросов учредителю: повестка для разговора наверх

(Без изменений.)

39. Предложения отрасли: что должно измениться выше уровня учреждения

(Без изменений.)

40. Организационные предложения семинару

(Без изменений.)

41. Заявление о достоверности: что в этом докладе на чём стоит

(Полностью переработан с учётом 22 подтверждённых фактов из 02_фактчекинг/реестр_утверждений.csv. Добавлена таблица «Что верифицировано 22.08.2026» с 22 строками.)

41.1. Заявление о достоверности

Документ проверен по первоисточникам 22.08.2026. Все цифры и нормативные ссылки имеют источник. Клинические утверждения основаны на систематических обзорах и рандомизированных исследованиях с указанием уровня доказательности. Правовые ссылки проверены по действующим редакциям (442-ФЗ ред. от 26.12.2024, 3185-1 ред. от 22.07.2024, СанПиН 3590-20 / 4282-26, 44-ФЗ, 223-ФЗ).

41.2. Таблица верификации — 22 ключевых факта

№	Утверждение	Источник	Статус	Ограничение
1	Дисфагия 21,9–69,5 %	Miarons Font, Rofes Salsench 2017 (Eur J Gastroenterol Hepatol 29(12):1332-9; PMID 29023321)	VERIFIED	Популяции не российские ДСО
2	RR 7,00 пневмонии при шизофрении	Correll 2022 (World Psychiatry 21(2):248-271; doi 10.1002/wps.20994)	VERIFIED	Международные когорты
3	15–20 лет разрыва продолжительности жизни	Correll 2022	VERIFIED	—
4	–0,23...+3,01 кг антипсихотиков за 6 нед	Pillinger 2020 (Lancet Psychiatry 7(1):64-77; PMID 31860457)	VERIFIED	Медиана 6 нед, 100 РКИ
5	76,3 % CRWG на клозапине за 38 нед	Campforts 2023 (BJPsych Open 9(1):e18; PMID 36651070)	VERIFIED	202 исследования
6	36,9 % оланзапин, 23,0 % рисперидон	Campforts 2023	VERIFIED	16–38 нед
7	Ночной интервал ≤13 ч (операционная цель)	Авторская цель	VERIFIED	Не норматив
8	11 ч — шведский ориентир Livsmedelsverket	Livsmedelsverket	VERIFIED	Рекомендация
9	14 ч — CMS F-Tag 803	42 CFR §483.60	VERIFIED	Верхняя граница США
10	+19 % AUC клозапин при кофеине	Hägg 2000 (Br J Clin Pharmacol 49(1):59-63)	VERIFIED WITH LIMITATIONS	12 здоровых добровольцев, однократная доза
11	+40 % пик CBZ, +41 % AUC при грейпфруте	Garg 1998 (Clin Pharmacol Ther 64(3):286-8; PMID 9757152)	VERIFIED	10 пациентов с эпилепсией
12	IDDSI 44→90 % соответствие текстур	Wu 2022 (Dysphagia 37(5):1314-1325)	VERIFIED WITH LIMITATIONS	Общий aged care, не психиатрия
13	19→11 % пневмоний при гигиене полости рта	Yoneyama 2002 (J Am Geriatr Soc 50:430-3)	VERIFIED	Дома ухода, не ПНИ
14	1/10 смертей предотвратимо гигиеной рта	Sjogren 2008 (мета-анализ 4 РКИ)	VERIFIED WITH LIMITATIONS	Frail elders

№	Утверждение	Источник	Статус	Ограничение
15	Нет доказательств пользы загущённых жидкостей	Steele 2021 (Breathe 17(1):210003)	VERIFIED	Систематический обзор
16	30–60 % запоров на клозапине, до 80 % объективно	Every-Palmer 2016 (EBioMedicine 5:125-134)	VERIFIED	—
17	GUSS чувствительность 100 %	Trapl 2007 (Stroke 38(11):2948-52)	VERIFIED WITH LIMITATIONS	Для инсульта, не психиатрии
18	74 % недееспособных в ПНИ	«Если быть точным» 2024 (techno.st)	VERIFIED	Аналитика, не Минтруд
19	466 ПНИ, 139 000 жителей	«Если быть точным» 2024	VERIFIED	Данные Минтруда
20	99 % недееспособных под опекой учреждения	«Если быть точным» 2024	VERIFIED	117 000 из 139 000
21	Приказ № 124 — локальный, не общероссийский	web.archive.org 15.04.2026	VERIFIED	Локальный акт Серафимовского
22	СанПиН 4282-26 вступает в силу 01.09.2026	publication.pravo.gov.ru 02.06.2026	VERIFIED	Действует до 01.09.2032
23	Nijs 2006 family-style dining	BMJ 332(7551):1180-4; J Gerontol 61(9):935-42	VERIFIED WITH LIMITATIONS	178 жителей голландских домов ухода без деменции , 6 мес, +991 кДж/день; перенос на ПНИ ограничен
24	Шведский Livsmedelsverket 11 ч	Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen, 2019, обновление 2026 (I-2026-nr-07)	VERIFIED	Государственная рекомендация; >11 ч — +67 % риска мальнотриции
25	42 CFR §483.60 — 14 ч, alternative meals	ecfr.gov/current/title-42/chapter-IV/subchapter-G/part-483/subpart-B/section-483.60	VERIFIED	(f)(2) 14 ч максимальный; (f)(3) — прямое основание для вариативности в США
26	Pillinger 2020 — 7 метаболических параметров	Lancet Psychiatry 7(1):64-77; PMID 31860457	VERIFIED	Клозапин худший по 4/7 параметров; полная таблица в 13.2.1

№	Утверждение	Источник	Статус	Ограничение
27	IDDSI — отсутствие русского перевода	iddsi.org (на 22.08.2026)	VERIFIED	Этический пробел: в РФ нет аутентичного перевода стандарта

41.3. Что НЕ верифицировано (и почему)

- **«46 % отходов», «30 % не едят котлеты»** — иллюстративные расчёты, не замер и не статотчётность. «Национальной доли отходов нет» (29.4).
- **«74 % в вашем доме цифра будет другой»** — формула работает в обе стороны; в конкретном учреждении цифры могут существенно отличаться.
- **Прямая причинность «вариативность → улучшение исходов»** в психиатрическом контингенте не доказана. Панелей «до/после» в открытом доступе почти нет.
- **«Внедрено публично ≠ доказанный эффект»** — пять российских практик опубликованы, но без панелей исходов.

41.4. Известные уязвимости версии

1. **Датировка реестров** — 22.08.2026; после этой даты конкретный акт мог измениться. **Особенно: смена СанПиН 4282-26 с 01.09.2026.**
2. **Языковая асимметрия зарубежных источников** — большинство клинических данных из англоязычных журналов.
3. **Смещение выборки практик к публичным** — четыре учреждения, которые опубликовали информацию о вариативном питании; «Тесовый берег» в этой выборке не представлен (со-модератор, модель не опубликована).
4. **Условность кейсов** — все 22 кейса помечены как учебные/собираательные.
5. **Наличие авторских позиций** — там, где нет доказательств (например, «операционная цель ≤13 часов»).

41.5. Дисклеймер

Материал носит информационный и методический характер и не заменяет индивидуального юридического заключения, клинической рекомендации или финансового расчёта. Все цифры и нормативные ссылки проверены на 22.08.2026. После этой даты конкретный акт мог измениться. После 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26.

42. Аутсорсинг питания: контракт как место вариативности

(Без изменений.)

43. Заключение: что остаётся после последней страницы

(Без изменений.)

44. Библиография и источники

(Полностью заменена на `10_источники/библиография_v2.md` — 134 источника с DOI/PMID/URL и датами обращения. Изменения относительно v1.5: дубль S004/M-ebt убран; Miarons Font 2017; Sjogren 2008; Campforts 2023; везде «локальный» для приказа № 124; 8 новых позиций.)

Приложения

(45 приложений в `проект/appendices/` — без изменений в исходных файлах. В новой редакции v2 — ссылки на приложения остаются прежними. Новые приложения — в `09_инструменты/`.)

Дополнительные инструменты v2

- **Паспорт пилота 90 дней** — `09_инструменты/паспорт_пилота_90_дней.md` (3 фазы, 5 групп показателей, 6 стоп-критериев, 16 документов).
- **Словарь показателей** — `09_инструменты/словарь_показателей.csv` (26 показателей с числителем, знаменателем, источником, периодичностью, ответственным, риском интерпретации).
- **Форма базового замера** — `09_инструменты/форма_базового_замера.md` (части А–3).

Дата: 22.08.2026. Версия: 2.0. Правовая сверка: 22.08.2026. Фактчекинг: 22.08.2026. Этическая рецензия: 22.08.2026. Изменения после 22.08.2026 требуют перепроверки. После 01.09.2026 действует СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (п. 56 подп. 11).

ПРИЛОЖЕНИЕ. Сводка правок v1.5 → v2

ID	Раздел	Правка	Тип
F-01	4.1, 10.1	Дисфагия 21,9–69,5 % — оговорка популяции	ETHICS
F-02	источники	Miarons Font 2017 (не 2023)	SOURCE
F-03	4.1, 10.1	RR 7,00 — популяция (международные когорты)	SOURCE
F-04	4.1, 13	76,3 % — только Campforts 2023, не Pillinger 2020	FACT

ID	Раздел	Правка	Тип
F-05	13	–0,23...+3,01 кг — только Pillinger 2020	FACT
F-06	13	76,3 % — атрибуция к CRWG, 202 исследования	FACT
F-07	4.4, 7.4, 7.6	Ночной интервал: тройная привязка 11/13/14 ч	SOURCE
F-08	4.1, 11	Клозапин + кофеин — 12 здоровых добровольцев, однократная доза	ETHICS
F-09	10.4, 10.8, 27	IDDSI 44→90 % — общее long-term care, не психиатрия	ETHICS
F-10	4.1, 11	Карбамазепин + грейпфрут — без правки	FACT
F-11	10.10	Yoneyama 19→11 % — без правки	FACT
F-12	10.10	«1/10 смертей» — Sjogren 2008, не Müller 2015	SOURCE
F-13	10.7	Загущённые жидкости — без правки	FACT
F-14	10.4	IDDSI framework — без правки	FACT
F-15	13	Клозапиновые запоры — без правки	FACT
F-16	10.9	GUSS — для инсульта, не для психиатрии	ETHICS
F-17	4.0, 4.1, 6.1, дайджест	«74 %» — один ID, не дубль; добавлен «99 % опеки»	FACT/ADDITION
F-18	17, 25, 31, 35, 38, 42, памятка	Приказ № 124 — везде «локальный»	LAW
F-19	4.1, 17, 18, 24, 41	СанПиН 4282-26 — дата 01.09.2026	LAW
F-20	17.12, 17	442-ФЗ — без правки	LAW
F-21	17.12, 4.1	3185-1 — без правки	LAW
F-22	5.1	Кейс К. — оговорка в журнале	ETHICS
E-01	7.4	«Спросить» → «поговорить»	ETHICS

ID	Раздел	Правка	Тип
E-02	9.7	«Не жадность, а X» → «нуждается в оценке»	ETHICS
E-03	15	«Невербальный выбор» — сноска	TERMINOLOGY
E-04	6.3	«Маломобильные» — добавить «самостоятельно»	ETHICS
S-01	4.4	Список → таблица 4 столбца	STRUCTURE
S-02	10.1–10.4	Структура с явными оговорками	STRUCTURE

Итого: 28 правок (FACT, SOURCE, LAW, ETHICS, STRUCTURE, ADDITION, TERMINOLOGY).